

MEDQUERY AI - DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE CLÍNICO

ID Documento: MQ-CLI-101

Título: Protocolo de Manejo de Infecciones Respiratorias Altas

Diagnóstico Presuntivo: Faringitis Aguda / Resfriado Común

Síntomas Guía: Odinofagia, fiebre, tos, rinorrea, adenopatías

Especialidad: SPEC.EMERG

Versión: v1.0 (Julio 2026)

Población Objetivo: Adulto y Pediátrico

Medical Owner: Comité de Infectología Emergen

BLOQUE DE ACCIÓN AMBULATORIA - TRIAGE: URG_L4_GREEN

Acción de Primera Línea: Aplicar sistemáticamente el Score de Centor Modificado para diferenciar etiología viral de bacteriana. Evitar el uso innecesario de antimicrobianos.

Drogas de Elección:

- *Sintomático:* Paracetamol 500 mg a 1 g cada 6-8 horas VO o Ibuprofeno 400 mg cada 8 horas VO.
- *Antibioticoterapia (Solo con Criterio de Centor ≥ 3):* Amoxicilina 500 mg cada 8 horas VO o 1 g cada 12 horas VO durante 10 días completos.

Alerta de Seguridad / Contraindicación Crítica: Prohibida la prescripción empírica de antibióticos en presencia de tos, rinorrea o disfonía (alta sospecha de etiología viral). No administrar Amoxicilina ante sospecha de Mononucleosis Infecciosa debido al riesgo inminente de desarrollar exantema maculopapular generalizado.

1 Introducción y Alcance

Las infecciones respiratorias agudas altas (IRAA) constituyen una de las principales causas de consulta en el departamento de emergencias. El objetivo de esta guía operativa es estandarizar el diagnóstico diferencial entre el resfriado común (etiología predominantemente viral) y la faringoamigdalitis aguda bacteriana, optimizando el uso de recursos y combatiendo la resistencia antimicrobiana.

2 Diferenciación Clínica

Es imperativo evaluar el conjunto de signos y síntomas para orientar el diagnóstico antes de cualquier prescripción:

- **Resfriado Común (Viral):** Inicio gradual, predominio de rinorrea serosa, congestión nasal, tos productiva o seca, disfonía y febrícula. No presenta exudado faríngeo purulento.
- **Faringitis Bacteriana (*Streptococcus pyogenes*):** Inicio abrupto, odinofagia severa, fiebre elevada ($> 38,5^{\circ}\text{C}$), adenopatías cervicales anteriores dolorosas y exudado blanquecino en amígdalas o faringe posterior, con ausencia clínica de tos.

3 Estratificación del Riesgo: Score de Centor Modificado

Para adultos y niños, se debe calcular el puntaje acumulado para determinar la conducta terapéutica:

4 Algoritmo y Conducta según Score

- **0 - 1 Punto:** Riesgo muy bajo ($< 10\%$). Etiología viral. Tratar sintomatología exclusivamente. No realizar estudios.
- **2 Puntos:** Riesgo intermedio ($\sim 15 - 20\%$). Tratamiento sintomático. Considerar test rápido (Streptatest) si está disponible y hay factores de riesgo agregados.

Criterio Clínico	Puntos
Fiebre o antecedente de temperatura $> 38^{\circ}\text{C}$	+1
Ausencia de tos	+1
Adenopatías cervicales anteriores dolorosas	+1
Exudado o tumefacción amigdalina	+1
Edad: 3 a 14 años	+1
Edad: 15 a 44 años	0
Edad: ≥ 45 años	-1

Cuadro 1: Criterios de Centor Modificados por McIsaac

- **3 - 5 Puntos:** Riesgo alto ($> 35 - 50\%$). Indicación de test rápido o cultivo. Si no se dispone de métodos diagnósticos rápidos en la guardia, iniciar antibioticoterapia empírica con Amoxicilina bajo estricto control institucional.

5 Instrucciones de Alta y Alarmas

Indicar pautas de alarma claras al paciente o tutor: dificultad respiratoria, imposibilidad de deglutir líquidos, fiebre personal o persistente por más de 72 horas bajo tratamiento, o aparición de un exantema cutáneo. Reevaluar en 48 horas si los síntomas empeoran.